兒童肝膽胃腸科常見疾患及處置要點 [2025 年 08 月更新]

主治醫師 江文山 賴明瑋 趙舜卿 陳建彰 張魁文 陳世彥 葉宏瑀 賴宏香 葉栢睿 陳米琪 張恩碩 蘇莞心 指導校訂
總醫師 黃振全 張淳翔 王宜薇 謝惠翔 代表編輯

兒童肝膽胃腸科常規

- ✧ 每周四早上 7:30 於 12L 討論室舉行兒童胃腸科晨會(內容包括 Orientation, 病歷討論會，Journal reading 以及 Case conference 等)
- ✧ 請各位醫師接門診新病人時先看過住院通知單及門診 note 開立 order，如有不清楚請與 senior R 或 VS 詢問 (盡量挑非門診時段詢問)
- ✧ 值班隔日下班前請確實交班並完成當日 note
- ✧ 如遇某 VS 大量進新病人時,請住院醫師互相 cover, 也可以請當科或非當科 clerk 來接病人及完成 admission note (Admission note 有本科 AGE 範本)
- ✧ 急診簽床順位: W1 蘇莞心 W2 蘇莞心 W3 趙舜卿 W4 陳建彰 W5 賴明瑋

兒童腸胃科住院病人一般處置原則

1. 若為急性腸胃炎,檢驗項目一般開立：CBC/DC, electrolytes, renal function, sugar, CRP, blood culture, stool routine, Rotaviral antigen (L72-918), Norovirus RNA (L72-911), stool cultures for *Salmonella, Shigella* and *Campylobacters*，特定病人（有腸胃道病史等）考慮加驗 *C. difficile* stool culture 及 CD toxin (L72-690)
2. 急性細菌性腸胃炎病人使用抗生素之 Indication：
   A) Extraintestinal involvement (**bacteremia**, arthritis, osteomyelitis, meningitis)
   B) Immunocompromised, including young infant ≤ 12 months (especially ≤ 3 months)
   C) Severe symptoms (Severe diarrhea, high/persistent fever)
   D) Major GI disease (Hirschsprung disease, IBD)
   E) Complicated GI condition (toxic megacolon, surgical abdomen)
   - ➢ 抗生素之選擇常用為 Ceftriaxone, dosage 50-100mg/kg/day Q12H
3. Biliary tract infection：過去曾接受膽道手術者（biliary atresia, choledochal cyst）須考慮此一診斷，抗生素之選擇常用為 Ceftriaxone ± Metronidazole，視嚴重度而定
4. 禁食的原則:
   A) 嚴重嘔吐(持續吐膽汁、大量 coffee ground 或 fresh blood)
   B) 腹脹及持續性劇烈腹痛
   C) 臨床上無法排除急性腹症
   D) 意識狀態不清

點滴輸液

1. 除了計算 maintenance 還需考慮脫水及參考 Electrolytes data，例如腸胃炎吐拉很嚴重，可以給予 Taita No.2 或 Taita No. 3，如果沒有灌水的禁忌症，點滴可給多一些增加腸道循環（1.2-1.5 倍 maintain）
2. 常用點滴

	電解質(mEq/L)							Dextrose (g / L)	Cal/L	PH	mOsm/L
	Na	K	Cl	Ca	P (mM/L)	Mg	Acetate/ Lactate				
Taita No.1	25	18	20	0	6	3	20 / 0	38	129	5-6	300
Taita No.2	40	12	26	0	6	0	20 / 0	33	112	5-6	287

Taita No.3	75	12	61	0	6	0	20 / 0	20	68	5-6	285
Taita No.4	110	20	102	0	12	0	16 / 0	8	27	5-6	300
Taita No.5	36	18	17	0	12	3	28 / 0	100	340	5-6	669
L-R	130	4	109	3	0	0	0 / 28	0	0		273
D5S	154	0	154	0	0	0	0	50	0		586
D2.5 S1/2	77	0	77	0	0	0	0 / 0	25	85		280
D5 S1/4	38.5	0	38.5	0	0	0	0 / 0	50	170		355

脫水狀態之臨床評估(Evaluation for dehydration in pediatric patients)

1. 可由生病前體重(pre-illness weight)評估。評估方式為：$\frac{\text{生病前體重}-\text{現在體重}}{\text{生病前體重}}\times 100\%$
2. 若無體重資料，則可參考表格，由臨床觀察來評估脫水程度：

	Mild	**Moderate**	**Severe**
Infant (≦6 m/o)	5% (50 mL/kg)	10% (100 mL/kg)	15% (150 mL/kg)
Older child	3% (30 mL/kg)	6% (60 mL/kg)	9% (90 mL/kg)
Skin turgor	Normal	Tenting	None
Buccal mucosa/lips	Moist	Dry	Parched
Eyes	Normal	Deep set	Sunken
Tears	Present	Reduced	None
Fontanelle	Flat	Soft	Sunken
Pulse rate	Normal	Slightly increased	Increased
Urine output	Normal	Decreased	Anuric

Reference: THE HARRIET LANE HANDBOOK 18th ed

兒童急性腹症(Acute abdomen)

1. 腸套疊(intussusception)：若已成功實行 Air reduction 且症狀已緩解者，原則上禁食 0-6 小時，視病人臨床狀況及穩定度調整
2. 急性闌尾炎(acute appendicitis)：
   A) 若診斷為急性闌尾炎，需照會小兒外科醫師作開刀之評估
   B) 抗生素：常用 Ceftriaxone + metronidazole
3. 嵌頓型疝氣(incarcerated hernia)：需照會小兒外科
4. 梅克爾氏憩室(Meckel's diverticulum)：需做 Meckel's scan (N73-034)
5. Intestinal malrotation with midgut volvulus：需照會小兒外科
6. 腸沾黏(adhesion ileus)：過去曾接受過腹部手術者，皆需考慮此一診斷

肝功能異常、黃疸與肝腫瘤的評估

1. 完整的肝功能檢驗：請點兒童腸胃科範本「Liver function test」，包括 ALT, AST, total and direct bilirubin, albumin, sugar, ALK-P, rGT, PT, aPTT, Ammonia
2. 疑似病毒性肝炎者，需做病毒血清學檢驗，可參考兒童腸胃科範本「Viral hepatitis」：
   - Hepatitis A virus: anti-HAV IgM
   - Hepatitis B virus:
     - For screening: HBsAg, Anti-HBc IgM
     - 若 HBsAg (+), Anti-HBc IgM(-): check HBeAg, Anti-HBe
     - 考慮治療時，會驗 HBV DNA viral load (M23-078)
   - Hepatitis C virus: anti-HCV Ab，陽性考慮治療者加做 HCV-RNA detection, HCV genotyping 等
   - Cytomegalovirus: CMV IgM, CMV IgG, urine shell vial (L72-902)

- Epstein-Barr virus: EBV-CA IgM, EBV-CA IgG, EB-EA (L72-949), EB-NA (L72-950)
（註：EB EA+NA 為耳鼻喉科評估 NPC 之項目，請勿開立）

3. Wilson's disease survey：可參考 Scoring system 幫助診斷
   - Ceruloplasmin (L72-225), 24hr urine copper (L72-345，檢體改 U)
   - 若 24hr urine copper 介於 50-100，或臨床無法排除，會進一步做 **Challenge test**：請點兒童腸胃科範本「Penicillamine challenge test」，給予口服銅螯合劑 d-penicillamine 500mg(無論體重)Q12H 共兩劑，第一個 dose 吃下後就開始留尿，驗 24hr urine copper
   - 眼科會診 For Kayser-Fleischer ring
   - 視臨床安排 Brain MRI
   - 若高度懷疑，需驗基因
4. Autoimmune hepatitis survey：請點兒童腸胃科範本「Autoimmune hepatitis panel」，autoimmune liver profile (M25-158)、 ANA、Smooth muscle Ab (L72-255)、IgG (若 IgG 高，再加驗 IgG 1, IgG 2, IgG 3, IgG 4)
5. 新生兒黃疸之評估
   - 完整的肝功能檢驗
   - 影像檢查：腹部超音波**（請 NPO 4 小時）**，視檢驗檢查結果安排 MRCP、Liver biopsy

開立兒童超音波檢查

1. 檢查單：小兒科檢查→Abdominal echo for multiple organs (M32-063)，務必註明**診斷以及檢查目的**，若需評估肝膽胰請空腹 4 小時，若需評估子宮卵巢需漲尿
2. 若**兩年內相同適應症**做過檢查，請開立 Echo, Follow (M23-032-Z)
3. 若檢查部位非腹腔內構造，如頸部、腋下、肚臍、腹股溝、睪丸等部位，請由小兒科檢查→soft tissue echo (inguinal/head/neck/extremities) (S46-202-Z3)
4. 若主治醫師想指定時段或為急症但排程已滿，請與檢查室(8240)聯繫

開立內視鏡醫囑(必須經過腸胃專科醫師會診評估後始可開立)

★排程時間請與總醫師確認

★大於 12 歲的病人若需麻醉，需簽署自費同意書

- 上消化道內視鏡檢查：開立 M23-120-Z，自費 2000 元
- 下消化道內視鏡檢查：開立 M23-121-Z，自費 2500 元
- 上加下消化道內視鏡檢查：開立 M23-122T-Z，自費 3500 元
- 例外：若大於 12 歲但為 CP、mental retard、自閉症等無法配合之病人，則**無需自費**; 另外**治療性處置(異物夾除、EV ligation 等)**也無需自費; 需注意**糞便移植 FMT 不算在治療性處置，因此大於 12 歲仍需自費**

★病人需同時進行上消化道與下消化道內視鏡時，請分別開立檢查單與同意書

1. 上消化道內視鏡(panendoscopy, PES)
   - 點選兒童腸胃科「Pandoscope」範本，內有檢查單 panendoscopy (M32-203)
   - 簽具檢查同意書
   - 於前一天晚上禁食(midnight NPO)
   - 檢查室常備止痛及鎮靜藥物，不需開立藥囑，但小於 12 歲或大於 12 歲有自費麻醉需於檢查前完成中重度鎮靜同意書之填寫
   - 胃鏡「治療」者，請依照不同需求開立不同單號，並簽具消化道內視鏡治療同意書

2. 下消化道內視鏡(colonfiberscopy)
   - 點選兒童腸胃科「Colonfiberscopy」範本，內有檢查單 Colonfiberscopy (M32-207)
   - 簽具檢查同意書
   - 檢查前 1-3 天開始低渣飲食，檢查當日吃清流質飲食(liquid diet)，midnight NPO
   - 緩瀉劑：請與總醫師確認擇其一使用
     - PEG：自費 250 元
     - Bowklean powder 保可淨：1 劑自費 290 元，需使用 2 劑
     - Magnesium citrate 250ml/bot：健保，現多用於無法配合大量喝水的小小孩，劑量為成人 1PC，6-12 歲 100-150ml，6 歲以下 2-4ml/kg/dose
   - Fleet Enema：劑量為 5-10 ml/kg/dose（每劑最多 1PC = 118 ml），檢查前一天 10PM 及檢查當天早上 8AM 各一次
   - 檢查室常備止痛及鎮靜藥物，不需開立藥囑，但小於 12 歲或大於 12 歲有自費麻醉需於檢查前完成中重度鎮靜同意書之填寫
   - 大腸鏡「治療」者，請依照不同需求開立不同單號，例如經由大腸鏡接受息肉切除者，請將原大腸鏡檢查單 DC，改開立 polypectomy (M32-221)並更改同意書

肝臟生檢(Liver biopsies)

1. 點選兒童腸胃科「Liver biopsy」範本，內有檢查單 Liver biopsy (M32-028)
2. 簽具 Liver biopsy 檢查同意書（在成人 GI「肝臟生檢同意書」）
3. 檢查前須確定病患無出血傾向與血小板低下(Check CBC/DC, PT, aPTT)
4. 檢查前 NPO 6 小時
5. 鎮靜止痛藥物：Midazolam + Ketamine ± Lidocaine (外用, 1%, 5 mL/amp)
6. U/C 盒 x1，福馬林檢體罐 x1（檢查當天早上請助理員至病理科領取），沙袋 x1 (0.5-2 kg，視病人體型決定)，空針筒(5 mL, 20 mL 各一)，手套，紗布
7. 檢查前與主治醫師確認是否須加作電顯檢查，若需要，檢查當天早上需請助理員至病理科領取，領回後冰存
8. 檢查後，請找一台可以列印+掃條碼的電腦，開立醫囑「P71-035」，開立後會跳出**病理組織檢查委託單**
   - 掃描同意書條碼
   - 完成委託單內容，包括臨床診斷（若有指定病理科醫師或附電顯檢體，請寫在此）、病摘、Lab
   - 檢體件數無論有無電顯檢體，一律寫「1 件」
   - 完成後存檔列印，護理師才能繼續刷送檢條碼
9. Post Liver-Biopsy Order:
   - Check BP at least Q8H for 1 day
   - 完全清醒才可以進食
   - Keep right decubitus position and compression by sandbag（小小孩 1kg，大小孩 2kg）for 6 hours
   - Bed rest for one day

直腸黏膜抽吸切片檢查(Rectal suction biopsies)

1. 點選兒童腸胃科「Suction biopsy」範本，內有檢查單 Rectal suction biopsy (M32-029)
2. 簽具 Suction biopsy 檢查同意書（在兒童外科部「兒童直腸抽吸切片檢查」）
3. 檢查當天 CM NPO
4. 檢查時，分別距肛門口 5 cm 及 3 cm 處（通常先採 5 cm 再採 3 cm），採檢左右兩邊

之黏膜，共四個檢體

5. **檢查後**，開立病理組織委託單：P71-402（次數 Key 1）& P71-002（次數 Key 2）
   - 請依次填寫：Rectum 5 cm、Rectum 3 cm、Enzyme 5 cm, Enzyme 3 cm

腹水引流與相關檢驗(Ascites tapping and laboratory evaluation)

1. 以下檢驗項目 serum 及 ascites 各一套：total protein, albumin, sugar, LDH
2. 腹水相關檢驗：ascites fluid routine, fluid cytology, Gram's stain, ascitic culture (common aerobics, anaerobic, mycobacteria)
3. 其他檢驗
   - Milky/chylous ascites: check ascitic total triglyceride
   - Greenish ascites: check ascitic total bilirubin
   - Gut perforation or pancreatitis: check ascitic amylase, lipase
   - Malignancy-related: check ascitic tumor marker (根據腫瘤種類而定)

紫質症及相關檢驗(Porphyria)

1. 若不明原因腹痛，紫質症是需要考慮的診斷，其他可能症狀包括神經學症狀、橘色尿液等
2. 檢驗
   - Screening: Urine porphyrin (L72-709, spot urine), urine coporphyrin (L72-711, spot urine)
   - 若上述 Screening test positive, 需近一步驗 24hr urine: A-ALA (L72-411, 24hr urine), porphobilinogen (L72-413, 24hr urine)，因會受到光線影響，會以鋁箔紙包裹送件

- 若上述檢驗 positive，可進一步做基因檢測：AIP HMBS gene screening (L72-688)

24 小時食道酸鹼阻抗檢查(24hr PH monitor)

1. 欲開立此項檢查，請先電聯會診總醫師安排時間
2. 若有使用制酸劑、Prokinetics 等，需停藥至少 3 天
3. 點選兒童腸胃科「24hr PH monitor」範本，內有檢查單 Multi-channel intraluminal impedance and PH monitor (M32-222)
4. 請使用「消化道內視鏡檢查同意書」，檢查名稱填寫「24 小時食道酸鹼阻抗檢查」
5. 檢查照完 X 光後，請聯絡總醫師確認 Monitor 位置

肛管放置(Rectal tube placement)

1. 原則上，肛管之尺寸及置入深度選擇如下：成人 Fr 22-30（置入約 7.5-10cm），兒童 Fr 14-22（置入約 5-7.5cm），嬰兒 Fr 12（置入約 2.5-4cm），但視糞便性狀及臨床症狀做調整
2. 放入前，在肛管上剪零星的洞幫助減壓效果
3. 放置深度依照上述參考深度，或至有阻力為止

兒童經靜脈營養(Pediatric parenteral nutrition)

1. 長庚醫院 TPN 製劑配方表(節錄，2012 年 09 月最新，參考臨床藥理科網頁)

Each 1L contains	**Neonatal**	**Peripheral**	**Ped ST**	**Standard**	**High Nutrition**	**Hepatic**	**Renal**
Amino acid (g)	25	25	40	42.5	60	33.5	35
Equivalent mL to 1 g/kg	40	40	25	23.5	16.7	29.8	28.6

Calories (Kcal)	440	440	704	1020	801	926	905
Dextrose (g)	100	100	160	250	165	233	225
Na^+ (mEq)	40	40	50	30	30	30	18
K^+ (mEq)	20	20	30	28	28	28	0
Ca^{2+} (mEq)	30	6	15	2	2	2	4
P (mM)	9	9	7	13.5	13.5	13.5	13.5
Mg^{2+} (mEq)	4	4	7	10	10	10	0
Cl^- (mEq)	20.6	46.6	70	38.2	38.2	38.2	0
Zn (mg)	2.84	2.84	5	2.84	2.84	2.84	1.1
MVI (mL)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Acetate	26	15	24	25.5	36	0	0
Trace Element (mL)	0	0	0	0	0	0	0

2. TPN 計算方式:醫囑需呈現 g/kg/day 及流速(ml/hr),周邊 IV 不超過 1g/kg/day,Central line 不超過 3g/kg/day，以下為常用：
   - AA 2.5 TPN： 1g = 40ml, 1ml = 0.025g
   - AA 3.3 TPN： 1g = 30ml, 1ml = 0.033g
   - AA 3.5 TPN： 1g = 28.5ml, 1ml = 0.035g
   - AA 5 TPN（50g A.A. in 1000ml）： 1g = 20ml, 1ml = 0.05g
   - TPN Standard（成人，AA 4.25） ： 1g = 23.5ml, 1ml = 0.0425g
   - TPN Pediatric standard（AA 4.0）： 1g = 25ml, 1ml = 0.04g
3. SMOF lipid (20%, 100 or 250 mL/bottle)
   - 1g = 5ml, 1ml = 0.2g, 1ml contains 2.2 Kcal
   - 最高流速：0.15g/kg/hr = 0.75ml/kg/hr

糞便移植(Fecal microbiota transplantation)

1. 欲開立此項檢查，請先電聯總醫師確認排程時間，並與總醫師或主治醫師確認此次檢查為**自費**、**恩慈計畫（不需自費）**，或**任何其他原因而無需自費**
   - 若為自費：點選兒童腸胃科範本「自費 FMT」，內有檢查單 Fecal microbiota transplantation via colonscopy (M32-822，自費$13000)，同意書請使用**微菌叢植入治療同意書**（同意書→兒童內科部），再點選範本「Colonfiberscopy」，**刪去 Colonfiberscopy 檢查單(M32-207)**，其他 Colon prepare 醫囑同一般大腸鏡（NPO、確認緩瀉劑種類等）
   - 若為恩慈計畫或其他原因無須自費：醫囑開立同大腸鏡，點選兒童腸胃科範本「Colonfiberscopy」，使用 **Colonfiberscopy 檢查單(M32-207)**，同意書請使用**微菌叢植入治療同意書**（同意書→兒童內科部），其他 Colon prepare 醫囑也與一般大腸鏡相同（NPO、確認緩瀉劑種類等）
2. 大於 12 歲的病人需自費麻醉，簽署自費同意書（醫囑開立 M23-121-Z，自費 2500 元）
3. 檢查室常備止痛及鎮靜藥物不需開立藥囑，但小於 12 歲或大於 12 歲有自費麻醉需於檢查前完成中重度鎮靜同意書之填寫
4. Post-FMT Order：點選範本「Post-FMT Order」，完全清醒即可進食，移植後需完全平躺 2 小時，輕柔活動（盡量於床上）一天，避免上大號（必要時可與 VS 確認是否

開立止瀉藥物如 Imodium），若原先有使用抗生素，請與主治醫師確認是否在移植完後即 DC 抗生素

兒童肝膽胃腸科常用檢查與檢驗項目代碼一覽

腹　部　超　音　波		內　　視　　鏡	
Abdominal echo for multiple organs	M32-063	Panendoscopy	M32-203
Echo, follow	M23-032-Z	Pandoscopic polypectomy	M23-005-Z
其　他		Colonoscopy	M32-207
Rectal suction biopsy	M32-029	Colonscopy polypectomy	M32-221
Liver biopsy	M32-028	Esophageal variceal ligation	M32-212
C13 Urea breath test	L72-475	Dilation esophagus by ballon	M32-214
24HR pH Monitor	M32-222	Endoscopic ND tube placement	M32-203
Soft tissue echo	S46-202-Z3	Endoscopic injection sclerotherapy	M32-210
Fibroscan(自費$1500)	M23-029-Z	Endoscopic control of hemorrhage	S43-050-Z
上消化道內視鏡自費麻醉($2000)	M23-120-Z	Foreign body removal	M32-202
下消化道內視鏡自費麻醉($2500)	M23-121-Z	FMT(自費$13000)	M32-822
上+下消化道內視鏡自費麻醉($3500)	M23-122T-Z		

兒童肝膽胃腸科主治醫師超音波時段 (2025/09 更新)

Echo 時段 10:00-12:00, 14:00-16:30

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
上午	陳建彰 MA2841	趙舜卿 MA2456	蘇莞心 MA4278	蘇莞心 MA4278	趙舜卿 MA2456	
下午	劉嘉威 MA2335	劉嘉威 MA2335	賴明瑋 MA0758	陳建彰 MA2841	賴明瑋 MA0758	

兒童肝膽胃腸科主治醫師門診時間表 (2025/09 更新)

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
上午	蘇莞心 MA4278	陳建彰 MA2841	趙舜卿 MA2456 劉嘉威 MA2335	賴明瑋 MA0758 陳建彰 MA2841 曾文禹 MA1345	劉嘉威 MA2335	**(單週)** 陳建彰 MA2841
下午	**(林口)** 賴明瑋 MA0758 陳建彰 MA2841 **(桃園)** 趙舜卿 MA2456	賴明瑋 MA0758 趙舜卿 MA2456	**(林口)** 賴宏香 MA0667 **(土城)** **(單週)** 陳建彰 MA2841 **(桃園)** **(第 1 週)** 劉嘉威 MA2335 **(第 3 週)** 蘇莞心 MA4278	蘇莞心 MA4278	趙舜卿 MA2456 陳建彰 MA2841	（**第 1 週**） 蘇莞心 MA4278 **(雙週)** 賴明瑋 MA0758 **(第 3 週)** 劉嘉威 MA2335
夜間		**(雙週)** 劉嘉威 MA2335		**(1.3 週)** 劉嘉威 MA2335 （停診） **(雙週)** 趙舜卿 MA2456	蘇莞心 MA4278	

附錄：小兒腸胃科常用藥物

A. 常用藥物

MgO 250mg/tab	Adult (>12yrs): [Antacid] 1-1.5# QD-BID (max 800mg/day) [Laxative] 1g/day, BID-QID 6-12yrs: 1/2 adult dose 3-6yrs: 1/4 adult dose	制酸、輕瀉
Aluminum magnesium gel (AMG, Ulwycon susp.)	Adult (>12yrs): 10-15ml TID-QID 6-12yrs: 1/2 adult dose 3-6yrs : 1/4 adult dose	制酸、抗脹氣 自費 100 元/瓶
Ulwycon tab	Adult (>12yrs): 2# TID or PRN 6-12yrs: 1# TID 3-6yrs: 1/2# TID	制酸、抗脹氣 自費 2 元/PC
Magaldrate 400mg/tab (Peichia)	Adult (>12yrs): 1-2# TID 6-12yrs: 1/2 adult dose 3-6yrs: 1/4 adult dose	制酸
Alginate sodium susp. 50mg/ml, 210ml/pc	Adult (>12yrs): 10-20ml TID-QID 6-12yrs: 5-10ml TID-QID 0-2yrs: 1-2ml/kg/dose Q12H-Q8H	制酸 自費 340 元/瓶
Sucralfate •懸乳液 Gel susp. 10ml/sachet (100mg/ml) •錠劑 500mg/tab	Adult: 1g QID Children: 40-80mg/kg/day Q6H (0.1-0.2ml/kg/dose) (max 4g/day)	
Cimetidine (Tagamet)	IVF/PO: 5-10mg/kg/dose Q6H-Q8H	IVF run 15-20mins
Famotidine	Adult (>16yrs): IVF/PO 20mg Q12H Children (<16yrs): (max 40mg/day) [PO] 0.5-1mg/kg/dose QD-Q12H [IVF] 0.25-0.5mg/kg/dose Q12H	IVF run 15-30mins
Esomeprazole (Nexium)	IVF/PO: Adult: 20-40mg QD-Q12H Children: 1mg/kg/dose QD-Q12H	
Lansoprazole •口服膠囊：中化 •口服口溶錠：Takepron O.D.	IVF/PO: Adult (>12yrs): 30mg QD-Q12H Infant ≥3 months: 7.5mg Q12H or 15mg QD ≤11yrs, >30kg: 30mg QD ≤11yrs, ≤30kg: 15mg QD	
Domperidone 10mg/tab	Adult (>12yrs): 10mg TID Children: 0.25mg/kg/dose, TID	止吐、促胃排空
Mosapride 5mg/tab	Adult: 1# TID Children: 0.3-0.5mg/kg/day BID-TID	止吐

Metoclopramide (Primperan)	IV/IM/PO: Adult: 10-20mg/day, Q8H-Q6H Child: 0.1mg/kg/dose, Q8H-Q6H Continuous IVF infusion: not exceed 0.4mg/kg/day	止吐、促胃排空 EPS 解藥: Vena 1mg/kg/dose
Simethicone susp. 20mg/ml (Dimethicone, Gascon)	0.1ml/kg/dose, TID-QID	自費 200 元/瓶
Buscopan (Hyoscine)	IV/IM/PO: Adult (>12yrs): 20mg QID Child (6-12yrs): 10mg TID	
Lactulose	[Constipation] Adult: 15-30ml/day, max 60ml/day Child: 1.5-3ml/kg/day QD-BID, max 60ml/day [Encephalopathy] 見下頁「肝臟疾病用藥」	
Fleet enema 118ml/bot	5ml/kg/dose, max 1PC	
Ducolax supp.	>10yrs or >20Kg: 1# once 0-10yrs: 1/2# once	
Racecadotril (10mg/sachet)	(For child) 1.5mg/kg/dose, TID, max 60mg/dose	
Dioctahedral Smectite powder 3gm/sachet (Smecta)	>2yrs, adult: 1# TID 1-2yrs: 2/3# TID <1yrs: 1/3# TID	
Loperamide 2mg/cap (Imodium)	Adult: 1-2# PRN, max 8#/day Child: 0.08mg/kg/dose, BID-TID	
Alverine 60mg/cap	Adult (>12yrs): 1-2# QD-TID	
Biogen	Adult (>12yrs): 2-3# TID-QID 6-12yrs: 1/2 adult dose 3-6yrs: 1/4 adult dose	用於各種消化不良引起的症狀
Octreotide 100mcg/ml/amp For pancreatitis 劑量參考資料: Al-Hussaini A, Butzner D. Therapeutic applications of octreotide in pediatric patients. Saudi J Gastroenterol. 2012 Mar-Apr;18(2):87-94.	For diarrhea: SC: 1-10mcg/kg/dose, Q12H-Q8H Continuous IVF: 1mcg/kg/hr (dilute with N/S) For pancreatitis (from study 僅供參考): SC: Adult 100-200mcg Q8H Child 7.5mcg/kg/day Q8H Continuous IVF: 1mcg/kg/hr (dilute with N/S)	IVF 泡法參考(請依照水分需求及體重調整): Octreotide 250mcg in 250ml N/S run X ml/hr = [X/BW] mcg/kg/hr
Gabexate (FOY) 100mg/vial	For pancreatitis: Continuous IVF: 5-10mg/kg/day or 1-3PC/day dilute with D5W 500-1500ml; IVF rate≦ 8ml/min	Protease inhibitor IVF 泡法參考(請依照水分需求及體重調

		整): Gabexate 100mg in 500ml D5W run 20ml/hr

B. 益生菌

Biothree	Adult (>12yrs): 1-2# TID 6-12yrs: 1/2 adult dose 3-6yrs: 1/4 adult dose	每粒 $1.5*10^8$ 顆菌落 自費 9 元/顆
Lactobacillus rhamnosus (摩舒益多)	Adult (>12yrs): 1# QD-QID Children: 0.5-1# QD-BID	每粒 10^9 顆菌落 自費 18 元/顆
Lactobacillus casei (阿德比)	>2yrs: 2-6#/day <2yrs: 1-2#/day	每粒含 $2x10^8$ 顆菌落 自費 8 元/顆
Clostridium Butyricum Miyairi (妙力散)	仿單: Adult (>12yrs): 1PK TID 6-12yrs: 1/2PK TID 3-6yrs: 1/4PK TID 廠商: >3 歲: 3PK/天 2 歲: 2PK/天 1 歲: 1PK/天 6 個月以下: 0.5PK/Day	自費 15 元/顆
Infloran (益腹寧)	Adult (>12yrs): 1# TID-QID 6-12yrs: 1/2 adult dose 3-6yrs: 1/4 adult dose <3yrs: 1# QD	自費 25 元/顆

C. 肝臟疾病用藥

Silymarin 150mg/cap	Adult: 1# BID-TID Child: 5-10mg/kg/day BID-TID	
Ursodeoxycholic acid 100mg/tab	10-30mg/kg/day, max 600mg/day	
Lactulose	[Encephalopathy] produce 2-3 stools/day Adult: 30-45ml Q12H-Q6H Children: 40-90ml/day in divided doses Infant: 2.5-10ml/day in divided doses	
Vitamin K	Adult: Bleeding: 10mg/dose, IVF run 15-30 mins Nonbleeding: 5-10mg/dose, IVF run 15-30 mins Child: (參考) 0.1mg/kg/dose, IVF run 15-30 mins	一般使用 3 天